

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Senior Secondary School Term II Examination, 2022
Marking Scheme – PHYSICAL EDUCATION (SUBJECT CODE – 048)
(PAPER CODE –75)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and marks be awarded to them. In class-XII, while evaluating two competency based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, marks should be awarded.**
4. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
5. Evaluators will mark (✓) wherever answer is correct. For wrong answer ‘X’ be marked. Evaluators will not put right kind of mark while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
6. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
7. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
8. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out.
9. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

10. A full scale of marks _____(example 0-40 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
11. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e. 8 hours every day and evaluate 30 answer books per day in main subjects and 35 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
12. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past :-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
13. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
14. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
15. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
16. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
17. The Board permits candidates to obtain photocopy of the Answer Book on request in an RTI application and also separately as a part of the re-evaluation process on payment of the processing charges.

General Instructions.

- a. The making scheme carries only suggested value points for the answers.
- b. These are only Guideline and do not constitute the complete answer.
- c. The students can have their own expression and if the expression is correct, the marks be awarded accordingly.
- d. The candidates would be permitted to obtain a photocopy of the Answer book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation that is carried out strictly as per value points for each answer as given in the marking Scheme.
- e. All the Head Examiners/Additional Head Examiners/Examiners are instructed that while evaluating the answer scripts, if the answer is found to be totally incorrect, (X) should be marking on the incorrect answer and awarded '0' marks.

MARKING SCHEME

Senior Secondary School Examination TERM-II, 2022

शारीरिक शिक्षा- विषय कोड -48 पेपर कोड-75

प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर / नैतिक मूल्य बिन्दु	अंक
1	प्रश्न- "आसनों का उपयोग रोकथाम के उपाय के रूप में किया जा सकता है।" टिप्पणी करें। उत्तर-1) आसनों का उपयोग रोग -प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। 2) रक्त - संचार प्रणाली में सुधार करता है। 3) श्वसन- तंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। 4) तंत्रिका-तंत्र को मजबूत करता है। 5) उत्सर्जन - तंत्र को दक्षता प्रदान करता है। 6) अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित व विनियमित करता है। 7) एकाग्रता में सुधार करता है। 8) इस से शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। (कोई चार बिन्दु अथवा अन्य संबंधित बिन्दु)	2
2	प्रश्न- 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' लचक क्या है ? उत्तर- सक्रिय लचक:- जोड़ की बिना बाहरी सहायता के गतिविधि करने की योग्यता को सक्रिय लचक कहते हैं। इसमें बिना सहायक के खिंचाव को अधिकतम सीमा तक खींचा जा सकता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है -स्थिर लचक और गतिशील लचक। निष्क्रिय लचक:- इसे अक्रिय लचक भी कहा जाता है। यह साथी की सहायता से जोड़ की अधिकतम सीमा तक गतिविधि कराने की योग्यता रखता है। उदाहरण:- साथी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना।	1+1=2
3	प्रश्न- 'बाह्य अभिप्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है।' स्पष्ट कीजिए। उत्तर- बाह्य अभिप्रेरणा उन व्यवहारों को संदर्भित करती है जो धनराशि, प्रसिद्धि, ग्रेड तथा प्रशंसा जैसे बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होते हैं। यह सही है कि बाह्य अभिप्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है जैसे कोई खिलाड़ी /धावक बाह्य अभिप्रेरणा या किसी प्रोत्साहन या पुरस्कार के आकर्षणवश किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है परन्तु पुरस्कार-प्राप्ति के पश्चात् वह उस खेल में अपनी रुचि खो देता है और खेल को छोड़ देता है। उदाहरण के लिए बच्चे मनोरंजन और उत्साह के लिए क्रिकेट खेलना प्रारंभ करते हैं और नियमित रूप से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यास करने और प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। किन्तु प्रशिक्षक अथवा माता-पिता की सफलता की उम्मीदों को बोझ महसूस करते हैं। तत्पश्चात् खेलों में भाग लेने व व्यायाम करने के उद्देश्यों के बीच संघर्ष होने के कारण अक्रियाशील या निष्क्रिय से हो जाते हैं। परिणामतः धीरे-धीरे अपने प्रिय खेल से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं।	2

4	प्रश्न- दिव्यांगता (अक्षमता) को परिभाषित करते हुए, उसके किन्ही दो प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर- 1) दिव्यांगता (अक्षमता) किसी व्यक्ति की वह शारीरिक या मानसिक स्थिति है जो उसकी इन्द्रियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों या उन से जुड़ी गतिविधियों को या उनकी कार्य-प्रणाली को सीमित कर देती है। 2) दिव्यांगता (अक्षमता) किसी व्यक्ति की वह स्थिति है, जब वह कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। दिव्यांगता (अक्षमता) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">संज्ञानात्मक अक्षमता</th><th style="width: 33%;">बौद्धिक अक्षमता</th><th style="width: 33%;">शारीरिक अक्षमता</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) स्मरण शक्ति में विकार</td><td>1) तार्किकता</td><td>1) गतिशीलता</td></tr> <tr> <td>2) हाईपर एक्टिविटी (अतिसक्रियता)</td><td>2) अधिगम</td><td>2) शारीरिक क्षति</td></tr> <tr> <td>3) डिस्लेक्सिया</td><td>3) समस्या समाधान</td><td>3) श्वसन विकार</td></tr> <tr> <td></td><td>4) संचार</td><td>4) दृष्टि बाधा</td></tr> <tr> <td></td><td>5) निर्णय</td><td>5) मिर्गी</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>6) निद्रा विकार</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>7) गामक विकार</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>8) संवेदी क्षति</td></tr> </tbody> </table> (कोई 1 परिभाषा और कोई 2 प्रकार)	संज्ञानात्मक अक्षमता	बौद्धिक अक्षमता	शारीरिक अक्षमता	1) स्मरण शक्ति में विकार	1) तार्किकता	1) गतिशीलता	2) हाईपर एक्टिविटी (अतिसक्रियता)	2) अधिगम	2) शारीरिक क्षति	3) डिस्लेक्सिया	3) समस्या समाधान	3) श्वसन विकार		4) संचार	4) दृष्टि बाधा		5) निर्णय	5) मिर्गी			6) निद्रा विकार			7) गामक विकार			8) संवेदी क्षति	1 +0.5 +0.5 =2
संज्ञानात्मक अक्षमता	बौद्धिक अक्षमता	शारीरिक अक्षमता																											
1) स्मरण शक्ति में विकार	1) तार्किकता	1) गतिशीलता																											
2) हाईपर एक्टिविटी (अतिसक्रियता)	2) अधिगम	2) शारीरिक क्षति																											
3) डिस्लेक्सिया	3) समस्या समाधान	3) श्वसन विकार																											
	4) संचार	4) दृष्टि बाधा																											
	5) निर्णय	5) मिर्गी																											
		6) निद्रा विकार																											
		7) गामक विकार																											
		8) संवेदी क्षति																											
5	प्रश्न- प्राथमिक चिकित्सा के किन्ही दो उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर- (1) जीवन को बचाना। (2) पीड़ित की अवस्था को सुधारना। (3) मूर्च्छा (बेहोशी) आने से बचाना। (4) चोट अथवा बिमारी के प्रभाव को बढ़ने से रोकना। (5) दर्द को कम करना। (किन्ही दो का विवरण)	1+1=2																											
6	प्रश्न- समन्वय संबंधी योग्यता के दो प्रकारों को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर- 1) <u>प्रतिक्रिया योग्यता</u> :- ये किसी संकेत पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। ये योग्यता दो प्रकार की है- साधारण और जटिल। उदाहरण - 100 मीटर दौड़ का स्टार्ट। 2. <u>संतुलन योग्यता</u> :- यह स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था के दौरान संतुलन बनाए रखने की योग्यता होती है। उदाहरण- वॉटर-स्कीइंग या बैलेसिंग बीम पर संतुलन बनाना। 3. <u>लयबद्ध योग्यता</u> :- यह 'लय' को समझने तथा उसके अनुसार गति करने की योग्यता होती है। उदाहरण - इस प्रकार की योग्यता, तैराकी, जिम्नास्टिक, ड्राइविंग और स्केटिंग आदि में आवश्यक है। 4. <u>अनुकूलन योग्यता</u> - यह किसी स्थिति में परिवर्तन या प्रत्याशित परिवर्तनों के आधार पर संपूर्ण गति को बदलने की योग्यता कहलाती है। उदाहरण - द्वन्द्वात्मक खेल (जूड़ो, रेसलिंग) आदि।	1+1=2																											

	5. <u>विभेदन योग्यता</u> :- विभेदन योग्यता , गामक क्रिया के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर की अलग-अलग गतियों की मितव्ययता तथा गति पड़ावों से है । उदाहरण –बॉस्केट-बॉल के एक नौसिखाए खिलाड़ी द्वारा ड्रिब्लिंग करना तथा उसी खिलाड़ी द्वारा निरंतर अभ्यास के पश्चात् सटीकता से ड्रिब्लिंग करना । 6.<u>संयोजन योग्यता</u> :- यह संपूर्ण खेल-गतिविधियों में शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों को संयोजित करने की योग्यता है । उदाहरण -जैसे कदमताल व स्मैसिंग के दौरान हाथों, पैरों और आँखों के बीच सामंजस्य होना । 7.<u>अनुस्थापन योग्यता</u> :- शरीर की स्थिति को समय व स्थान के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार योग्य बनाने की योग्यता है । उदाहरण- तीव्र (स्प्रंटिंग)दौड़ के दौरान स्टार्टिंग ब्लॉक से उठना । (किन्हीं 2 बिन्दुओं का विवरण)	
7	प्रश्न- स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार (ए0एस0डी) के लक्षण बताइए । उत्तर- लक्षण – (1) वार्तालाप में कठिनाई होना । (2) एक ही व्यवहार को बार-बार दोहराना । (3) अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर पाना । (4) आँखें मिलाने से कतराना । (5) एक ही वस्तु को बार-बार छूना । (6) मित्रों का सीमित दायरा । (7) स्वाद, गंध और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता । (8) बोलने में कठिनाई होना । (9) सामाजिक मेलजोल से बचना । (10)अपनी रुचि को प्रकट न कर पाना तथा नाम से बुलाने पर प्रतिक्रिया न दे पाना । (किन्हीं 2 बिन्दुओं का विवरण)	1+1=2
8	प्रश्न- सहनक्षमता का निर्धारण करनेवाले किन्ही दो शरीर-क्रियात्मक कारकों का वर्णन कीजिए । उत्तर- सहनक्षमता को निर्धारित करनेवाले कारक निम्नलिखित हैं- 1) एरोबिक क्षमता । 2) ऑक्सीजन ग्रहण करना । 3) ऑक्सीजन उद्-ग्रहण करना । 4) दुग्ध अम्ल सहनशीलता । 5) गतिविधि मितव्ययता । 6) मांसपेशीय संरचना । 7) ऊर्जा भंडारण । (किन्ही दो का विवरण)	1+1=2

9	प्रश्न- प्रतिरोधक विद्रोही विकार (ओडीडी) के किन्ही चार कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर- प्रतिरोधक विद्रोही विकार के कारण निम्नलिखित हैं- 1) आनुवांशिक अथवा जैविक कारक :- माता-पिता का एडीएचडी व ओडीडी से पूर्व में पीड़ित होना। माता-पिता का अवसाद या बाई-पोलर विकार आदि का पाया जाना। 2) शारीरिक कारक :- मस्तिष्क में असामान्य मात्रा में रासायनिक पदार्थों का पाया जाना। 3) मनोवैज्ञानिक कारक- बच्चों का अपने माता-पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों का पाया जाना। बच्चों में मानसिक तनाव होने के कारण ओडीडी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। 4) सामाजिक कारक:- परिवार की वित्तीय स्थिति का दयनीय होना, परिवार में अनुशासन की कमी का होना, परिवार के सदस्यों की हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण भी ओडीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। (इससे संबंधित किन्ही अन्य 4 का विवरण)	2
	खण्ड-ब	
10	प्रश्न-आक्रामकता को परिभाषित करते हुए किन्ही दो प्रकार की आक्रामकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर- आक्रामकता :- इस प्रकार का व्यवहार किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है। (अथवा इससे संबंधित अन्य परिभाषा) प्रकार:- 1) शत्रूतापूर्ण आक्रामकता :- शत्रूतापूर्ण आक्रामकता क्रोध से प्रेरित होकर की गई प्रतिक्रिया से संदर्भित होती है जिसका उद्देश्य मात्र किसी को नुकसान पहुँचाना होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाना है। यह अनियोजित प्रतिक्रिया, आवेगवश भावनाओं से ओत-प्रोत होती है। इस आक्रामकता से प्रभावित व्यक्ति शारीरिक उत्तेजनावश अपने आप पर नियंत्रण खो देता है। 2) सहायक या निमित्त आक्रामकता :- इस प्रकार की आक्रामकता का मुख्य उद्देश्य है प्रदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करना। खिलाड़ी इस प्रकार की आक्रामकता से विरोधी को चोट पहुँचाता है क्योंकि वह अपनी विजय की संभावनाओं को बढ़ाना चाहता है। वह आक्रामकता किसी शत्रूता से भरी नहीं होती बल्कि लाभ प्राप्ति अथवा विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। मुखर व्यवहार :- मुखर व्यवहार में खिलाड़ी का विरोधी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने की बजाय खेल में हावी होने का लक्ष्य होता है। इसमें खिलाड़ी मानसिक रूप से विरोधी खिलाड़ी की मानसिक एकाग्रता को भंग करने का प्रयास करता है। (किन्हीं दो का विवरण)	1+2=3

11	प्रश्न-दिव्यांगता (अक्षमता) शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं ? विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क करते हुए किन्हीं चार दिव्यांगता (अक्षमता) शिष्टाचारों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर- दिव्यांगता (अक्षमता) शिष्टाचार का अर्थ विशेष दिशानिर्देशों के एक समूह से है जो विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से संपर्क करने से संबंधित है। मूलतः इसका तात्पर्य दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विनम्रता और सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना है। दिव्यांगता (अक्षमता) शिष्टाचार :- • दोनों ओर से सम्यक् वार्तालाप का होना। • दिव्यांग व्यक्ति से सीधे वार्तालाप करना। • उसके साथ अपनत्व की भावना रखना। • यदि आवश्यक हो तो संचार उपकरण जैसे संचार-पुस्तिका तथा संचार-यंत्रों का प्रयोग करना। • उस से धीमी आवाज में किंतु स्पष्ट वार्तालाप करना। • उसे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय देना। • वार्तालाप में शालीन भाषा का प्रयोग करना। • उस से आँख से आँख मिला कर बात करना। • कठोर न होकर उसके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना। • बिना चीखे चिल्लाए प्यार से सहज वार्तालाप करना। • यदि व्यक्ति जानकार है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। • यदि दुभाषिया मौजूद तो भी दुभाषिए की अपेक्षा दिव्यांग व्यक्ति से सीधे वार्तालाप करें। • दिव्यांग व्यक्ति से वार्तालाप करते समय अपने शरीर को उसके स्तर पर लाकर ही वार्तालाप करें। • बिना किसी हड़बड़ाहट के उसकी बात पूरे ध्यान से सुनें। • उसकी शारीरिक भाषा (बॉडी-लैंग्वेज) होठों की भाषा और चेहरे के भावों को भी पढ़ने का प्रयास करें तथा वार्तालाप करते समय अपने चेहरे के भावों को भी उचित रखें। उसे आपके चेहरे पर परेशानी न नज़र आए। • उसकी बात समझने में यदि परेशानी हो रही हो तो भी उसे अपनी बात समझाने के लिए उचित समय देना चाहिए जिस से वह सही ढंग से अपनी बात को समझा सके। • वार्तालाप करते हुए लघु प्रश्नोत्तरी का ही प्रयोग करें। • दृष्टिबाधित व्यक्ति के संपर्क में आने पर वार्तालाप करने से पहले स्वयं का परिचय दें। (किन्हीं चार बिन्दुओं का विवरण)	1+2=3
----	--	-------

12	प्रश्न- किन्हीं 2 प्रकार की अस्थि चोटों का चित्र बनाकर, उनके प्रबंधन का वर्णन कीजिए। उत्तर- अस्थि चोटों का चित्र	1.5
		+1.5
		=3
	   	
तनाव	कच्ची	बहुखंड
	आड़ा-तिरछा	तिर्यक्
	पचड़ी	
अस्थिभंग का प्रबंधन :- क) तनाव अस्थिभंग :- 1) आराम करें जब तक अस्थि स्वयं न ठीक हो जाए। 2) प्रभावित अंग पर 24 से 48 घंटे तक हर दो घंटे में 15-20 मिनट के लिए बर्फ का प्रयोग करें। 3) चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह से दर्द निवारक औषधि लें। 4) प्रभावित क्षेत्र को स्थिर रखने की यदि आवश्यकता हो तो स्पलेंट का प्रयोग करें। 5) सूजन के समाप्त हो जाने पर प्रभावित क्षेत्र पर आंशिक रूप से भार डालें। 6) कम से कम 6 हफ्तों तक उस क्रिया को करने से बचें, जिस कारण तनाव अस्थि भंग हुआ है। 7) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए। ख) कच्ची अस्थि भंग :- 1) प्लास्टर की सहायता से चोटिल अंग को स्थिर करें। 2) चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दी गई दवा सूजन को कम करेगी। 3) दर्द-निवारक दवा का प्रयोग करें। 4) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए। ग) बहुखंड अस्थि भंग :- 1) अस्थि भंग क्षेत्र के ऊपरी और निचले भाग को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर व खप्पच्चियों का प्रयोग करें। 2) चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह से दर्द-निवारक दवा का प्रयोग करें। 3) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए। घ) आड़ा-तिरछा अस्थि भंग :- 1) यदि हल्का सा अस्थि भंग है तो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। 2) यदि स्थिति गंभीर है तब अथवा मेरूदंड के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ऑपरेशन आवश्यक है। 3) दर्द-निवारक दवा का प्रयोग करें और कोई भी काम या गतिविधि से बचें। 4) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए।		

	ड)तिर्यक्/तिरछा अस्थि भंग :- 1) अधिकांश तिर्यक्/तिरछा अस्थि भंग के उपचार के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। 2) अत्यधिक क्षति होने पर धातु की छड़ों और पेचों का इस्तेमाल कर अस्थि को स्थिर किया जाता है। 3) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए। च)पच्चड़ी अस्थि भंग :- 1) अस्थि को स्थिर करने के लिए स्लिंग या स्पलेंट का प्रयोग करें। 2) गंभीर केस में सर्जरी आवश्यक है। 3) अस्थि के सामान्य अवस्था में आने पर फ्रीज़ियो थेरेपी दी जाए। (किन्हीं दो प्रकार की अस्थि चोटों के चित्र और प्रबंधन) <u>दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए</u> किन्हीं दो प्रकार की अस्थि चोटों व उनके प्रबंधन के बारे में लिखिए। उत्तर :- पूर्ववत्	
13	प्रश्न- 'मत्स्यासन' के लाभ व विपरीत संकेत लिखिए। उत्तर- मत्स्यासन के लाभ :- 1. मत्स्यासन गर्दन और कंधों के तनाव को दूर कर उनकी मांसपेशियों में लचीलापन देता है। 2. मत्स्यासन बंद छाती को खोलता है और घुमावदार (गोल) कंधों की त्रुटि को ठीक करने में सहायक होता है। 3. मत्स्यासन गहरी श्वास द्वारा श्वसन तंत्र के किसी भी रोग को ठीक करने में सहायक होता है। फेफड़ों की अधिकतम क्षमता के विकास में सहायक होता है। 4. यह आसन (पीछे की ओर झुकी हुई घुमावदार रीढ़) मेरूदंड के घुमाव (आर्क) के कारण पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। 5. इस आसन से सर्वाइक और थोरेसिक रीज़न में रक्त संचार बढ़ता है जिस कारण से पैराथायराइड, पीयूष और पीनियल ग्रंथियाँ मजबूत बनती हैं। 6. मत्स्यासन का अभ्यास गर्दन व कंधों की मांसपेशियों के तनाव और अकड़न को कम करता है। अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में सर्पोन्डिलाइटिस की प्रारंभिक अवस्था के इलाज में सहायक होता है। 7. इसके बार बार के अभ्यास से गर्दन में लचीलापन आता है और लचीली गर्दन होने के कारण वह व्यक्ति दूसरे कठिन आसन भी सरलता से कर सकता है। 8. मत्स्यासन मानसिक तनाव को दूर करने सहायक होता है। <u>मत्स्यासन करने में सावधानियाँ / विपरीत संकेत :-</u> 1. हृदय रोगियों और उच्च-रक्तचाप और निम्न-रक्तचाप वाले रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। 2. माईग्रेन तथा इंसोमनिया वाले रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए।	1.5 +1.5 =3

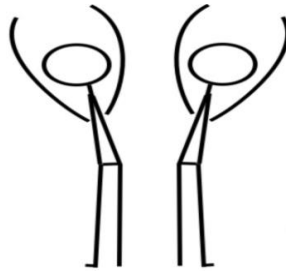
	3. गर्दन और पीठ के निचले भाग में चोट या समस्या वाले व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए 4. पेट की शल्य चिकित्सा तथा हर्निया वाले व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए 5. यदि इस आसन को करते हुए दिल घबराए या गर्दन में सर्वाइकिल के कारण दर्द होने लगे तो ये आसन नहीं करना चाहिए 6. अगर व्यक्ति को पैट्रिक अल्सर हो तो उसे भी यह आसन नहीं करना चाहिए 7. यह आसन किसी प्रशिक्षित निरीक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए (कोई 3 लाभ और कोई 3 विपरीत संकेत)																			
14	प्रश्न- आइसोमेट्रिक और आइसोटॉनिक व्यायाम के बीच अंतर को उचित उदाहरण दे कर समझाइए उत्तर- आइसोमेट्रिक और आइसोटॉनिक व्यायाम के बीच अंतर :- <table><tr><th>आइसोमेट्रिक व्यायाम</th><th>आइसोटॉनिक व्यायाम</th></tr><tr><td>1) इनमें किसी स्थिर प्रतिरोध के विरूद्ध माँसपेशियों का स्थिर संकुंचन शामिल होता है </td><td>1)इनमें क्रियाएँ गतिशील होतीं हैं परन्तु क्रियाओं में निरंतर गति की आवश्यकता नहीं होती है </td></tr><tr><td>2)इसका प्रयोग कुछ ही खेलों में किया जाता है जैसे – जिम्नास्टिक, भार प्रशिक्षण, कुश्ती इत्यादि </td><td>2)यह सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावी शक्ति प्रशिक्षण है जिसे ज्यादातर सभी खेलों में प्रयोग किया जाता है </td></tr><tr><td>3) इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का विकास होता है </td><td>3)इसके द्वारा विस्फोटक शक्ति विकसित होती है </td></tr><tr><td>4) आइसो का अर्थ समान तथा मेट्रिक का अर्थ लम्बाई होता है इस प्रकार के मांसपेशीय संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहती है </td><td>4)आइसो का अर्थ समान तथा टॉनिक का अर्थ खिंचाव होता है इस प्रकार की मांसपेशियों में बदलाव होता है या फिर वे छोटी या लंबी होती हैं </td></tr><tr><td>5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक है </td><td>5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक नहीं है </td></tr><tr><td>6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक नहीं रहती है </td><td>6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक रहती है </td></tr><tr><td>7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास नहीं होता है </td><td>7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास होता है </td></tr><tr><td>8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में कोई योगदान नहीं है </td><td>8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में बहुत योगदान होता है </td></tr></table>	आइसोमेट्रिक व्यायाम	आइसोटॉनिक व्यायाम	1) इनमें किसी स्थिर प्रतिरोध के विरूद्ध माँसपेशियों का स्थिर संकुंचन शामिल होता है	1)इनमें क्रियाएँ गतिशील होतीं हैं परन्तु क्रियाओं में निरंतर गति की आवश्यकता नहीं होती है	2)इसका प्रयोग कुछ ही खेलों में किया जाता है जैसे – जिम्नास्टिक, भार प्रशिक्षण, कुश्ती इत्यादि	2)यह सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावी शक्ति प्रशिक्षण है जिसे ज्यादातर सभी खेलों में प्रयोग किया जाता है	3) इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का विकास होता है	3)इसके द्वारा विस्फोटक शक्ति विकसित होती है	4) आइसो का अर्थ समान तथा मेट्रिक का अर्थ लम्बाई होता है इस प्रकार के मांसपेशीय संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहती है	4)आइसो का अर्थ समान तथा टॉनिक का अर्थ खिंचाव होता है इस प्रकार की मांसपेशियों में बदलाव होता है या फिर वे छोटी या लंबी होती हैं	5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक है	5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक नहीं है	6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक नहीं रहती है	6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक रहती है	7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास नहीं होता है	7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास होता है	8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में कोई योगदान नहीं है	8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में बहुत योगदान होता है	3×1=3
आइसोमेट्रिक व्यायाम	आइसोटॉनिक व्यायाम																			
1) इनमें किसी स्थिर प्रतिरोध के विरूद्ध माँसपेशियों का स्थिर संकुंचन शामिल होता है	1)इनमें क्रियाएँ गतिशील होतीं हैं परन्तु क्रियाओं में निरंतर गति की आवश्यकता नहीं होती है																			
2)इसका प्रयोग कुछ ही खेलों में किया जाता है जैसे – जिम्नास्टिक, भार प्रशिक्षण, कुश्ती इत्यादि	2)यह सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावी शक्ति प्रशिक्षण है जिसे ज्यादातर सभी खेलों में प्रयोग किया जाता है																			
3) इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का विकास होता है	3)इसके द्वारा विस्फोटक शक्ति विकसित होती है																			
4) आइसो का अर्थ समान तथा मेट्रिक का अर्थ लम्बाई होता है इस प्रकार के मांसपेशीय संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहती है	4)आइसो का अर्थ समान तथा टॉनिक का अर्थ खिंचाव होता है इस प्रकार की मांसपेशियों में बदलाव होता है या फिर वे छोटी या लंबी होती हैं																			
5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक है	5)यह स्थिर रहने वाले जोड़ों के पुनर्वास में सहायक नहीं है																			
6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक नहीं रहती है	6)इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक रहती है																			
7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास नहीं होता है	7)इससे समन्वय तथा कौशलों का विकास होता है																			
8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में कोई योगदान नहीं है	8)इसका सहन-क्षमता तथा गति को विकसित करने में बहुत योगदान होता है																			

	9) व्यायाम करते हुए क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।	9) व्यायाम करते हुए क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।	
	10) थकी हुई मांसपेशियों को शक्ति की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) धीमे होती है।	10) थकी हुई मांसपेशियों को शक्ति की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) तेजी से होती है।	
	11) उदाहरण :- दीवार को धक्का देना, लटकना आदि	11) उदाहरण :- पुश-अप, पुल-अप, रस्सी पर चढ़ना, बैच-प्रेस आदि	
	(किन्हीं 3 का विवरण)		
15	प्रश्न- ' बिग फाइव ' थ्योरी के अनुसार व्यक्तित्व की विशेषताएँ बताइए। उत्तर-1. खुलापन :- इस प्रकार के व्यक्ति नए-नए कामों को करनेवाले, कल्पनाशील, खुले विचारों के तथा बहुत जिज्ञासु होते हैं। 2. कर्तव्यनिष्ठ:- इस प्रकार के व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान, जिम्मेदार, विचारशील, अनुशासित, सुव्यवस्थित, समय के पाबंद, विश्वनीय और उच्चकोटि के नैतिक मूल्य रखते हैं। 3. बहिर्मुखता :- इस प्रकार के व्यक्ति सकारात्मक भाव रखने वाले, सामाजिक, ऊर्जावान, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखनेवाले और निस्संकोची अर्थात् खुल कर बात करने वाले होते हैं। 4. सहमतता:- इस प्रकार के व्यक्ति विश्वासपात्र, ईमानदार, अनुभूतिपूर्ण, स्नेही, सहयोगी, दयालु और सभ्य आचरण वाले चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। 5. मनोविक्षुब्धता :- इस प्रकार के व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील होने के कारण भावनात्मक स्तर पर अस्थिर, उदास, जिद्दी, स्वैच्छिक तथा अनियंत्रित आवेगों वाले होते हैं। (किन्हीं 4 का विवरण)		4×1=4
16	प्रश्न- हृदय-वाहिका श्वसन तंत्र पर व्यायाम के दो दीर्घकालिक व दो लघुकालिक प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर- <u>व्यायाम के हृदय-वाहिका श्वसन तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव :-</u> - हृदय के आकार में वृद्धि। - दुग्धामल का कम मात्रा में संग्रह होना। - विश्राम (आराम) की अवस्था में हृदयगति में कमी। - रक्तदाब का सामान्य होना। - स्ट्रोक आयतन व कार्डियक आउट के विकास में वृद्धि। - हृदय की मांसपेशियों का मजबूत होना। - डायफ्राम की मांसपेशियों का मजबूत होना। - फेफड़े के आयतन में वृद्धि। - प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि।		2+2=4

	10.लाल रक्त कणिकाओं व श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि । 11.असक्रिय (निष्क्रिय) वायु कोशिकाओं का सक्रिय हो जाना । 12.अवशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि । <u>व्यायाम के हृदय-वाहिका श्वसन तंत्र पर लघुकालिक प्रभाव :-</u> 1. हृदय गति में वृद्धि । 2. रक्त संचार में वृद्धि । 3. रक्त दबाव में वृद्धि । 4. स्ट्रोक आयतन में वृद्धि । 5. कोट्रियक आउटपुट में वृद्धि । 6. श्वसन क्रिया की दर में वृद्धि । 7. टायडल आयतन में वृद्धि । 8. ऑक्सीजन उदग्रहण में वृद्धि । (हर एक से किन्हीं दो का विवरण)	
17	प्रश्न- सहन-क्षमता को परिभाषित करते हुए सहन-क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में चर्चा कीजिए । उत्तर- सहनक्षमता :- एक गतिविधि को निरंतर बनाए रखने की क्षमता या किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियात्मक क्षमता जो उसे किसी समयावधि में गति में बनाए रखती है । या थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता । <u>सहन-क्षमता को विकसित करने की विधियाँ :-</u> 1. निरंतर प्रशिक्षण विधि 2. अंतराल प्रशिक्षण विधि 3. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि 1.निरंतर प्रशिक्षण विधि:- • इसको बिना विराम दिए लगातार किया जाता है । व्यायाम की तीव्रता इसमें कम रहती है परन्तु इसको लंबे समय तक किया जाता है । उदाहरण :-कॉसकन्ट्री दौड़ । • हृदयगति दर 140-160 प्रति मिनिट के बीच में रहती है । • व्यायाम की संपूर्ण अवधि 30 मिनिट से कम नहीं होनी चाहिए । • इसमें धीमी निरंतर दौड़ तथा तीव्र दौड़ हो सकती है । 2.अंतराल प्रशिक्षण विधि:- • पुनः प्राप्ति (रिकवरी) के सिद्धान्त के प्रभाव के आधार पर प्रत्येक गति अभ्यास के पश्चात् धावक को पुन प्राप्ति (रिकवरी) की अवधि दी जाती है । • धावक की क्षमता के अनुसार पुन प्राप्ति (रिकवरी) की अवधि में सामंजस्य किया जा सकता है । • पुन प्राप्ति (रिकवरी) की अवधि को कम करके भार को बढ़ाया जा सकता है । उदाहरण:- 1) 80% गति के साथ 400 मीटर दौड़ना ।	1 + 3 = 4

	2) कार्य करना या धीमी गति से तब तक दौड़ना जब तक हृदय गति एक मिनट में 120 से 140 न आ जाए। 3) व्यायाम की पुनरावृत्ति धावक की क्षमता या उसके अनुभव पर निर्भर करती है। 3. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि :- • इसका अर्थ "स्पीड-प्ले" है। • यह निरंतर तथा अंतराल विधि का सम्मिश्रण है। • इसमें ऐरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रणालियों पर जोर रहता है। • गति तथा चाल पहले से तय नहीं होती है। उसे खिलाड़ी के विवेक पर छोड़ा जाता है। गति को आस-पास के वातावरण के अनुसार बदला भी जा सकता है। (पहाड़ी, नदी, जंगल, ऊबड़-खाबड़, सड़क इत्यादि) • प्रशिक्षण की अवधि धावक के अनुभव पर निर्भर करती है। उसकी हृदय गति 140 से 180 प्रति मिनट होनी चाहिए। (कोई 1 परिभाषा और 3 प्रकार)	
18	प्रश्न- मोटापे से क्या अभिप्राय है? मोटापे के नियंत्रण के लिए सुझाए गए किन्हीं दो आसनों का चित्र बनाइए तथा उनकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर- मोटापा वह स्थिति है जिसमें व्यक्तिके शरीर में वसा की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जाती है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसे इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक (बीएमआई) 30 किलोग्राम/मीटर 2 हो अथवा इससे अधिक हो। अथवा "मोटापा एक निपेक्ष शब्द है जिसमें वसीय ऊतकों का जमाव अधिक होता है।" (अथवा इससे संबंधित अन्य परिभाषा) क) वज्रासन का चित्र :-  वज्रासन प्रक्रिया :- 1) सर्वप्रथम अपने घुटने के बल फर्श पर बैठें। ध्यान रहे फर्श पर आपके पंजे व टखने स्पर्श हो रहे हों। 2) पैर के पंजे पीछे की ओर तने हुए होने चाहिए। 3) दोनों हाथों की हथेलियाँ घुटनों के ऊपर रखें। 4) शरीर का ऊपरी भाग सीधा रखें। 5) लंबा गहरा श्वास भरें, रोकें, छोड़ें और श्वास पर नियंत्रण रखें। 6) मानसिक शान्ति के लिए आँखें बंद करें और श्वास पर ध्यान केन्द्रित करें। 7) यथा-स्थिति को 5-10 मिनट तक बनाए रखें।	1 +1.5 ×2 =4

ख)हस्तासन का चित्र



हस्तासन प्रक्रिया :-

- 1)दोनों पैरों को मिलाकर सीधा खड़े हों।
- 2)दोनों हथेलियों (दाएं व बाएं) को तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं।
- 3)दोनों हाथ कानों से सटे हुए सीधे रखें और शरीर में तनाव न रखें।
- 4)पैर के घुटनों को सीधा रखें।
- 5)झुकते हुए श्वास छोड़ें।
- 6) यथा-स्थिति को 5-10 मिनट तक बनाए रखें।

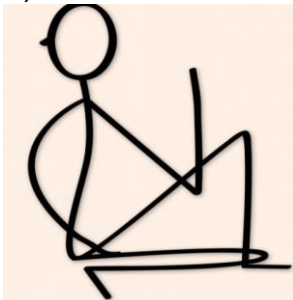
ग)त्रिकोनासन का चित्र :-



त्रिकोनासन प्रक्रिया :-

- 1) दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाएं।
- 2) दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फीट का अंतर रखें ताकि शरीर का भार संतुलित रहे।
- 3) दोनों हाथों को कन्धों के समानंतर रखें।
- 4) कमर से बाएं ओर झुकते हुए बाएं हथेली से बाएं टखने को पकड़ें।
- 5) दाहिना हाथ आकाश की ओर ऊपर ले जाएं तथा गर्दन को मोड़ते हुए आकाश की ओर देखें।
- 6) इसी अवस्था में 5 से 10 सैकिण्ड रहते हुए श्वास को सामान्य रखें।
- 7) इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं।

घ) अर्धमत्स्येन्द्रासन का चित्र :-



	अर्धमत्स्येन्द्रासन प्रक्रिया :- 1) आसन पर बैठते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। 2) बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं नितम्ब से लगाएं। 3) दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास में रखें। 4) दाहिने हाथ को बाएं घुटने के पीछे से ले जाते हुए बाएं टखने को पकड़ें/ बाएं पैर के तलवे को पकड़ें। 5) बाएं हाथ को कमर के पीछे की ओर ले जाकर फर्श पर रखें। 6) गर्दन को बाएं ओर मोड़ते हुए पीछे की ओर देखें तथा सामान्य रखें। <u>दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए</u> मोटापे के प्रबंधन / नियंत्रण के लिए उपयुक्त किसी एक योगासन की प्रक्रिया तथा उसके लाभों व विपरीत संकेतों का वर्णन कीजिए। उत्तर- वज्रासन के लाभ :- 1) वज्रासन से टखनों का लचीलापन बढ़ता है। 2) घुटनों को मोड़ने से जंघाओं की क्वाड्रिसेप (Quadriceps) मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है जिससे रक्त-संचार में सुधार होता है। 3) मेरूदंड में खिंचाव होने से पेडू की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं तथा रक्त-संचार का प्रवाह तीव्र होता है। 4) वज्रासन को भोजन उपरांत भी किया जा सकता है। यह पाचन-प्रणाली को शक्तिशाली बनाता है। 5) इसके अभ्यास से उदरक्षेत्र में रक्त-संचार बढ़ता है। 6) इस आसन के अभ्यास से मासिकधर्म-संक्रमण दूर होता है तथा साइटिका के दर्द में लाभ होता है। 7) यह पैष्टिक अल्सर व अति अम्लता के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। 8) इसके निरंतर अभ्यास से पेडू की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं जिसके कारण हर्निया से बचाव होता है तथा महिलाओं को प्रसूति में आसानी होती है। वज्रासन के विपरीत संकेत :- 1) पाइल्स के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 2) घुटने व एड़ियों के अस्थिबंध यदि क्षतिग्रस्त हों तो इसका अभ्यास बिल्कुल न करें। 3) यदि हर्निया व आंतों का अल्सर हो तो इस आसन का अभ्यास प्रशिक्षक की देखरेख व चिकित्सीय परामर्श के उपरांत ही करें। 4) धावक की यादें हेमिस्ट्रिंग व पिण्डली की मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त होने पर इसका अभ्यास न करें। 5) व्यक्ति को यदि घुटनों में गठिया का दर्द होने पर इसका अभ्यास न करें।	2+2=4
--	---	--

	2)हस्तासन के लाभ :- • मेरूदंड को लचीला बनाने में सहायक है । • यह मेरूदंड, पीठ और कमर का अच्छा व्यायाम है । • इस से कब्ज दूर होती है। • यह बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने में , कमर की चर्बी घटाने में और छाती को चौड़ा बनाने में सहायक है । हस्तासन के विपरीत संकेत:- • यदि कमर, गर्दन और पीठ में दर्द हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए । • साईटिका व गठिया के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए । 3) त्रिकोनासन 4)अर्धमत्स्येन्द्रासन (उपरिलिखित में से किन्हीं दो आसनों के 2 लाभ तथा 2 विपरीत संकेतों का विवरण)	